



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
TIM PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING*
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Tentang
Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

Penanggung Jawab:



(Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz.)

Disetujui Oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kep., AFP)

Ditetapkan Oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan pedoman ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.

TIM PENYUSUN

PENGARAH: Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PENYUSUN:

1. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.An., M.Biomed
2. Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz.
3. dr. Achmad Fauzan Ailani
4. Ayu Mayang Priningtyas, S.Kep.Ns
5. Iin Widowati, S.Tr.Keb.
6. Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
7. Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt.
8. Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANi

KATA PENGANTAR.....ii

TIM PENYUSUNiii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR GAMBARv

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADAvi

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Maksud dan Tujuan1

BAB II PENGORGANISASIAN3

 2.1 Struktur Organisasi (SOTK)3

 2.2 Susunan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*.....4

 2.3 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang.....4

 2.4 Tata Hubungan Kerja8

BAB III TATALAKSANA.....9

 3.1 Identifikasi dan Penetapan Pasien Risiko *Stunting* dan *Wasting*.....9

 3.2 Assesmen dan Penilaian Komprehensif.....9

 3.3 Penyusunan Rencana Pelayanan Terpadu10

 3.4 Pelaksanaan Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*10

 3.5 Monitoring Evaluasi Pasien *Stunting* dan *Wasting*10

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN11

BAB V PENUTUP12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. SOTK Rumah Sakit 3

Gambar 2. SOTK Tim pelayanan Stunting dan Wasting 3



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 935.104/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING*

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan pelayanan *stunting* dan *wasting*;
- b. bahwa pelayanan *stunting* dan *wasting* dilaksanakan secara integratif dan berkualitas melalui penerapan program penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting* Rumah Sakit Prima Husada;
- c. bahwa untuk mewujudkan poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 953.4/RSPHS/I/KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING***

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Intervensi Gizi Spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting*, *wasting* dan gizi buruk seperti asupan makan, infeksi, status gizi Ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- (2) *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK;
- (3) *Wasting* adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang mencerminkan berat badan anak terlalu kurus menurut tinggi badannya, ditandai dengan z-score BB/TB kurang dari -2 SD untuk *wasting* dan z-score BB/TB kurang dari -3 SD untuk *severe wasting*.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2 Pembentukan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Rumah sakit membentuk Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* melalui Surat Keputusan Direktur;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan;
- (3) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* di Rumah Sakit dipimpin oleh staf medis atau dokter spesialis anak;
- (4) Yang termasuk dalam keanggotaan tim pelayanan *stunting* dan *wasting* antara lain:
 - a) Staf Medis;
 - b) Staf Keperawatan;
 - c) Staf Instalasi Gizi;
 - d) Staf Instalasi Farmasi;
 - e) Tim Humas.

Pasal 3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* bertugas menyelenggarakan pelayanan *stunting* dan *wasting* secara komprehensif dan terintegrasi;
- (2) Tim berfungsi:
 - a) Melakukan skrining terhadap pasien dengan risiko atau diagnosis *stunting* dan/atau *wasting*;
 - b) Menyusun rencana pelayanan terpadu;
 - c) Melaksanakan intervensi sesuai kompetensi;



- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan;
- e) Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang meliputi: pelayanan gizi, pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 4

Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* melaksanakan koordinasi secara terintegrasi untuk menjamin pelayanan yang berkesinambungan, berfokus pada pasien, serta memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien;
- (2) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* melaksanakan pertemuan berkala untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan;
- (3) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* bertanggung jawab melakukan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelayanan kepada Direktur Rumah Sakit sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

BAB III

TATA LAKSANA

Pasal 5

Pelaksanaan Asesemen *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Setiap pasien anak usia 6-59 bulan dengan dugaan masalah gizi wajib dilakukan asesmen *stunting* dan *wasting* sesuai indikasi klinis dan standar pelayanan;
- (2) Asesmen dilakukan secara komprehensif meliputi pengukuran antropometri (BB/U, TB/U, BB/TB atau IMT/U), riwayat asupan gizi, riwayat penyakit, serta faktor sosial ekonomi;
- (3) Asesmen dilakukan secara multidisiplin oleh tenaga kesehatan terkait dan terdokumentasi dalam rekam medis;
- (4) Hasil asesmen menjadi dasar dalam penentuan diagnosis gizi serta penyusunan rencana intervensi dan tindak lanjut pasien.

Pasal 6

Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Pelayanan *stunting* dan *wasting* diberikan di unit pelayanan rumah sakit meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap, serta unit terkait lainnya;
- (2) Pelayanan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang mencakup edukasi gizi, intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- (3) Pelayanan dilaksanakan secara multidisiplin melibatkan tenaga medis, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien;
- (4) Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional, serta ketentuan yang berlaku;
- (5) Dilakukan koordinasi rujukan dan jejaring pelayanan untuk menjamin kesinambungan penanganan pasien *stunting* dan *wasting*.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 7



Monitoring dan Evaluasi

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan *stunting* dan *wasting* secara berkala;
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* menyusun laporan kegiatan dan capaian indikator mutu secara berkala;
- (2) Pelaporan hasil kegiatan dilaksanakan setiap bulan dan triwulan serta disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja;
- (3) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* melaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan melalui aplikasi “PELITA KESMAS”.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 2148.181/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Kerja Tim *Stunting* dan *Wasting* sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada Tanggal 1 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR 935.104/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN
STUNTING DAN *WASTING*

PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang menjadi prioritas nasional karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas sumber daya manusia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting menargetkan penurunan prevalensi stunting melalui intervensi terintegrasi, khususnya pada kelompok sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya ini menempatkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, sebagai unsur penting dalam mendukung pencapaian target nasional tersebut.

Rumah Sakit sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Nasional *Stunting*. Peran tersebut diwujudkan melalui pelayanan promotif dan preventif berupa skrining status gizi, edukasi, dan konseling gizi, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif bagi pasien dengan masalah gizi, termasuk stunting, wasting, dan gizi kurang. Pelaksanaan program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dan mendukung upaya penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pelaksanaan program stunting di rumah sakit dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi melalui kerja sama multidisiplin yang melibatkan dokter, perawat, bidan, ahli gizi, serta unit terkait lainnya. Kegiatan program mencakup deteksi dini, penatalaksanaan kasus, pemantauan tumbuh kembang, pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini mendukung peningkatan mutu pelayanan dan kesinambungan asuhan pasien, sekaligus memperkuat peran rumah sakit dalam upaya promotif dan preventif di bidang gizi masyarakat.

Rumah Sakit Prima Husada merupakan salah satu Rumah Sakit yang menerima rujukan dari FKTP dan FKTRL untuk kasus-kasus kegawatan dengan masalah gizi *stunting* dan *wasting*, selain itu juga terdapat pelayanan masalah gizi *stunting* dan *wasting* yang di kelola oleh tim pelayanan *stunting* dan *wasting* secara kontinyu dan sinergis menjalankan aktivitas pelayanan di bidangnya. Melalui implementasi program ini, Rumah Sakit Prima Husada diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan berkesinambungan, serta berkontribusi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* ini dimaksudkan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam membentuk, mengorganisasikan, dan



menyelenggarakan pelayanan *stunting* dan *wasting* melalui tim multidisiplin secara terstruktur, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, guna memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, standar pelayanan kesehatan, serta standar akreditasi rumah sakit

2. Tujuan Umum

Pedoman kerja tim pelayanan *stunting* dan *wasting* ini disusun sebagai acuan tenaga kesehatan dalam memberikan langkah pencegahan, penatalaksanaan dan pelayanan *stunting* dan *wasting* di Rumah Sakit Prima Husada

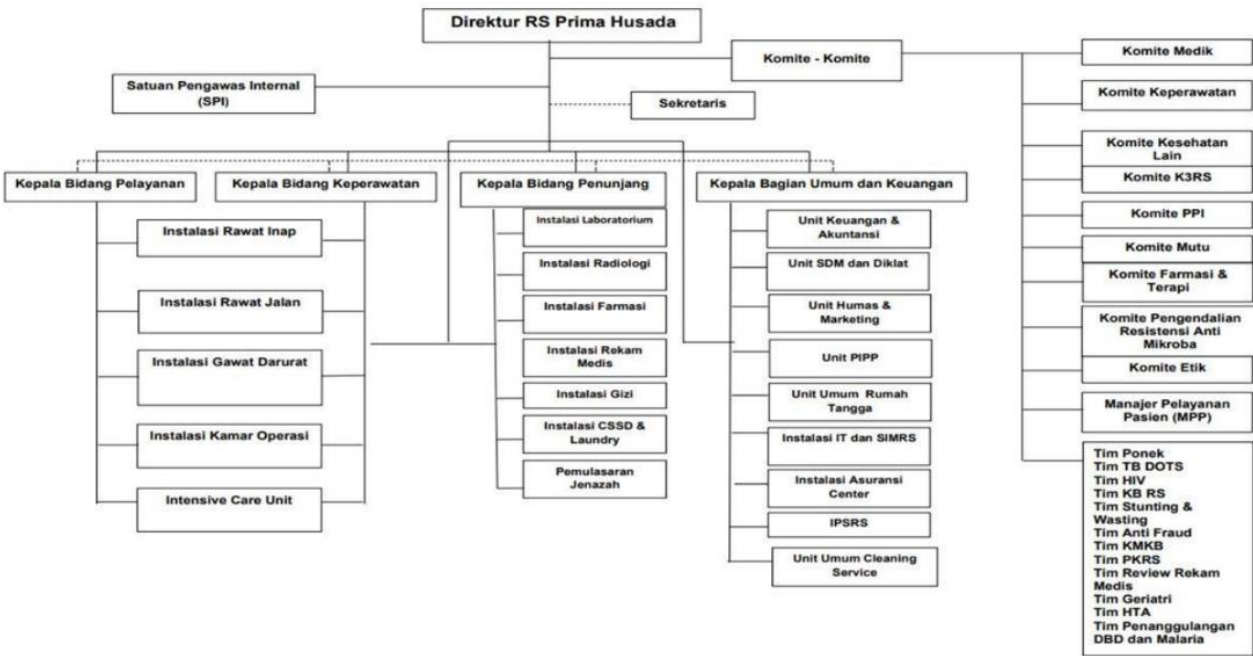
3. Tujuan Khusus

- a. Sebagai pedoman kerja bagi tim pelayanan *stunting* dan *wasting* dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas dan terperinci.
- b. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan intervensi gizi spesifik.
- c. Menyelenggarakan penatalaksanaan kasus *stunting* dan *wasting* secara komprehensif dan sesuai standar pelayanan.
- d. Meningkatkan pelaksanaan skrining dan deteksi dini masalah gizi *stunting* dan *wasting* pada bayi dan balita yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
- e. Meningkatkan edukasi, komunikasi, dan konseling gizi kepada pasien, keluarga, dan pendamping pasien sebagai bagian dari pelayanan berfokus pada pasien.
- f. Meningkatkan pencatatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi program *stunting* secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan.
- g. Memenuhi standar dan elemen penilaian akreditasi rumah sakit terkait program prioritas nasional dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

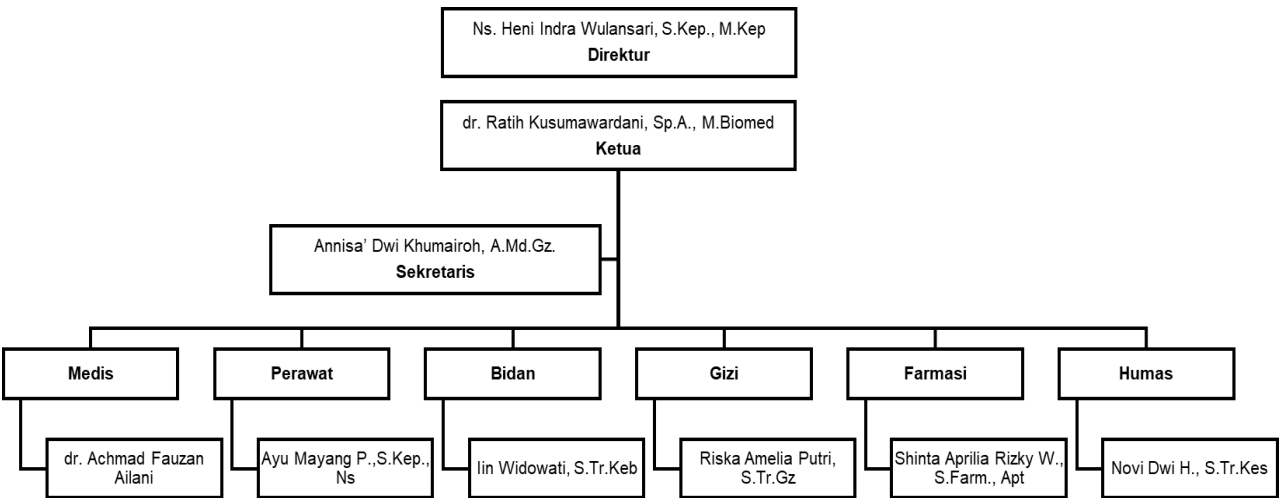


BAB II
PENGORGANISASIAN

2.1 Struktur Organisasi (SOTK)



Gambar 1. SOTK Rumah Sakit



Gambar 2. SOTK Tim pelayanan Stunting dan Wasting



2.2 Susunan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

Ketua	: dr. Ratih Kusumawardani, Sp.An., M.Biomed
Sekretaris	: Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz.
Anggota	:
Staff Medis	: dr. Achmad Fauzan Ailani
Staff Keperawatan	: Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns.
Staff Kebidanan	: Iin Widowati, S.Tr.Keb.
Staff Instalasi Gizi	: Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz.
Staff Instalasi Farmasi	: Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt.
Anggota Tim Humas	: Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes.

2.3 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

a. Ketua Tim

1. Kualifikasi:

- Staf medis, diutamakan dokter spesialis anak (Sp.A) yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
- Memiliki kompetensi dalam penanganan *stunting* dan *wasting*
- Memiliki pengalaman dalam pelayanan kesehatan anak di rumah sakit (min 3 tahun)
- Memiliki kemampuan kepemimpinan, koordinasi, dan manajemen tim yang baik
- Memahami pedoman nasional penanganan *stunting* dan *wasting* serta standar pelayanan rumah sakit.

2. Uraian Tugas:

- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim
- Menyusun kebijakan teknis serta strategi pelaksanaan pelayanan untuk pasien *stunting* dan *wasting*
- Mengarahkan pelaksanaan skrining, diagnosis, tata laksana, dan pemantauan pasien *stunting* dan *wasting*
- Mengkoordinasikan kerja sama antar profesi dalam tim pelayanan
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada pimpinan rumah sakit
- Mengembangkan peningkatan mutu pelayanan melalui pelatihan, audit klinis, dan evaluasi pelayanan

3. Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan *stunting* dan *wasting* yang efektif, terpadu, dan sesuai standar pelayanan
- Menjamin koordinasi antar tenaga kesehatan dalam tim berjalan dengan baik
- Menjamin pelayanan diberikan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, dan keselamatan pasien
- Bertanggung jawab atas pencapaian mutu pelayanan *stunting* dan *wasting*
- Bertanggung jawab terhadap laporan, data, dan semua informasi yang dikeluarkan oleh tim sebagai hasil pelaksanaan program kepada pimpinan rumah sakit dan ataupun dari dinas terkait

4. Wewenang:

- Menunjuk dan menetapkan sekretaris dan anggota tim
- Menetapkan rencana kerja dan kegiatan tim
- Mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh anggota tim dalam pelayanan
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tim.
- Memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit terkait pengembangan pelayanan *stunting* dan *wasting*
- Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk program *stunting* dan *wasting* sesuai dengan perundang-undangan.



b. Sekretaris Tim

1. Kualifikas:

- a) Tenaga kesehatan atau tenaga administrasi kesehatan yang ditunjuk oleh ketua tim
- b) Memiliki pendidikan minimal D-III
- c) Memiliki kemampuan administrasi, koordinasi, dan pengelolaan dokumen
- d) Memahami sistem pelaporan dan pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan
- e) Mampu bekerjasama dengan seluruh anggota tim.

2. Uraian Tugas:

- a) Mengelola administrasi kegiatan tim
- b) Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pertemuan tim.
- c) Menyiapkan dokumen, laporan, dan notulen rapat tim.
- d) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan pelayanan stunting dan wasting.
- e) Mengelola data dan dokumentasi kegiatan tim.
- f) Mendukung kelancaran koordinasi antar anggota tim

3. Tanggung Jawab:

- a) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan
- b) Menjamin ketepatan dan keteraturan pencatatan serta pelaporan kegiatan pelayanan stunting dan wasting
- c) Mendukung pelaksanaan program tim agar berjalan efektif dan terkoordinasi
- d) Bertanggung jawab pada ketua tim

4. Wewenang:

- a) Mengelola dan menyimpan dokumen kegiatan tim pelayanan stunting dan wasting
- b) Menghimpun data dan laporan dari anggota tim
- c) Menyampaikan informasi kegiatan tim kepada seluruh anggota tim
- d) Melakukan komunikasi internal dan eksternal kepada unit kerja lingkungan rumah sakit dan pihak luar melalui surat tertulis, email, ataupun telepon
- e) Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada ketua tim dan pimpinan rumah sakit

c. Anggota Tim

1. Staff Medis

a. Kualifikasi:

- 1) Dokter umum yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
- 2) Memiliki kompetensi dalam pelayanan kegawat daruratan dan penatalaksanaan awal masalah kesehatan anak, khususnya stunting dan wasting
- 3) Memahami skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal kasus stunting dan wasting pada bayi dan anak
- 4) Mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dalam pelayanan stunting dan wasting

b. Uraian Tugas

- 1) Melakukan skrining awal pada bayi dan anak dengan dugaan stunting dan wasting melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pengukuran antropometri.
- 2) Menegakkan diagnosis awal dan memberikan tata laksana medis sesuai kondisi
- 3) Menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan
- 4) Melakukan stabilisasi pasien apabila terdapat komplikasi
- 5) Berkoordinasi dengan dokter spesialis anak dan tim pelayanan stunting dan wasting



- 6) Melakukan rujukan internal atau eksternal bila diperlukan
 - 7) Mendokumentasikan pelayanan dalam rekam medis.
 - c. Tanggung Jawab
 - 1) Bertanggung jawab terhadap ketepatan diagnosis awal dan penatalaksanaan medis pasien
 - 2) Menjamin pelayanan medis diberikan sesuai standar profesi dan prosedur yang berlaku
 - 3) Menjamin keselamatan pasien selama pelayanan di IGD.
 - d. Wewenang
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian klinis pasien
 - 2) Menetapkan diagnosis awal dan tindakan medis yang diperlukan
 - 3) Meresepkan obat serta meminta pemeriksaan penunjang
 - 4) Melakukan konsultasi atau rujukan pada dokter spesialis anak atau unit terkait
2. Staf Keperawatan
- a. Kualifikasi:
 - 1) Pendidikan minimal Diploma III Keperawatan atau Profesi Ners
 - 2) Memiliki STR dan SIP Perawat yang masih berlaku
 - 3) Memiliki kompetensi dalam asuhan keperawatan anak dan pemantauan status gizi
 - b. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien stunting dan wasting
 - 2) Melakukan pengukuran tanda vital dan antropometri pasien
 - 3) Memberikan asuhan keperawatan sesuai rencana terapi medis
 - 4) Membantu pemantauan pemberian nutrisi dan terapi
 - 5) Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga
 - c. Tanggung Jawab
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan
 - 2) Memastikan keselamatan pasien selama perawatan
 - d. Wewenang
 - 1) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi
 - 2) Melakukan pemantauan kondisi pasien dan melaporkan perubahan pada dokter
3. Staf Kebidanan
- a. Kualifikasi
 - 1) Pendidikan minimal Diploma III Kebidanan atau Profesi Bidan
 - 2) Memiliki STR dan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) yang masih berlaku
 - 3) Memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan pertumbuhan balita
 - b. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan skrining awal risiko stunting dan wasting pada bayi dan balita
 - 2) Melakukan pengukuran antropometri (berat badan, panjang badan/tinggi badan, lingkar kepala)
 - 3) Memberikan edukasi pada ibu mengenai pemberian ASI, MP-ASI, pola asuh gizi
 - 4) Mendukung pemantauan tumbuh kembang anak
 - 5) Berkoordinasi dengan dokter dan tenaga gizi dalam pelayanan pasien
 - c. Tanggung Jawab
 - 1) Menjamin ketepatan pengukuran pertumbuhan bayi dan balita
 - 2) Melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai standar profesi dan operasional
 - d. Wewenang



- 1) Melakukan pelayanan kebidanan sesuai kompetensi
- 2) Melakukan deteksi dini masalah tumbuh kembang anak
- 3) Memberikan konseling kesehatan ibu dan anak

4. Staf Gizi

a. Kualifikasi

- 1) Pendidikan minimal Diploma III atau Sarjana Gizi/Nutrisi
- 2) Memiliki STR Tenaga Gizi dan SIP yang masih berlaku
- 3) Memiliki kompetensi dalam asuhan gizi klinik pada anak.

b. Uraian Tugas

- 1) Melakukan pengkajian status gizi pasien
- 2) Menetapkan diagnosis gizi
- 3) Menyusun intervensi gizi dan rencana diet pasien
- 4) Memberikan konseling gizi kepada pasien dan keluarga
- 5) Memantau dan mengevaluasi intervensi gizi yang diberikan

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan gizi pasien
- 2) Menjamin kesesuaian diet dengan kondisi klinis pasien

d. Wewenang

- 1) Menentukan rencana diet pasien
- 2) Memberikan edukasi dan konseling gizi.

5. Staf Farmasi

a. Kualifikasi

- 1) Pendidikan minimal Diploma III Farmasi atau Profesi Apoteker
- 2) Memiliki STR Tenaga Kefarmasian dan SIPA/SIK yang masih berlaku
- 3) Memahami pelayanan farmasi klinik

b. Uraian Tugas

- 1) Menyediakan obat sesuai resep dokter
- 2) Melakukan verifikasi resep dan memastikan ketepatan obat
- 3) Memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan
- 4) Memantau penggunaan obat pada pasien

c. Tanggung Jawab

- 1) Menjamin ketersediaan dan keamanan obat
- 2) Menjamin penggunaan obat yang rasional

d. Wewenang

- 1) Melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar
- 2) Memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga Kesehatan

6. Staf Humas

a. Kualifikasi

- 1) Pendidikan minimal Sarjana Kesehatan Masyarakat, Komunikasi, atau bidang terkait
- 2) Memiliki kompetensi dalam promosi kesehatan dan komunikasi publik

b. Uraian Tugas

- 1) Melaksanakan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan terkait stunting dan wasting
- 2) Menyusun media informasi, edukasi, dan komunikasi
- 3) Mendukung kegiatan penyuluhan dan kampanye kesehatan
- 4) Mengelola informasi dan publikasi kegiatan program stunting dan wasting.

c. Tanggung Jawab

- 1) Menjamin penyampaian informasi kesehatan yang benar dan mudah dipahami masyarakat



- 2) Mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting dan wasting.

d. Wewenang

- 1) Mengembangkan media komunikasi Kesehatan
- 2) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di lingkungan rumah sakit dan Masyarakat.

2.4 Tata Hubungan Kerja

1. Hubungan Internal Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

a. Ketua Tim dengan Anggota Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- 1) Ketua Tim mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*.
- 2) Ketua Tim memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*.
- 3) Ketua Tim memimpin diskusi tim dalam penyusunan rencana pelayanan pasien *Stunting* dan *Wasting*.
- 4) Anggota tim melaporkan hasil asesmen dan intervensi kepada Ketua Tim.
- 5) Ketua Tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan *stunting* dan *wasting*

b. Antar Anggota Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- 1) Setiap anggota tim melakukan assesmen sesuai dengan kompetensi profesi masing-masing.
- 2) Anggota tim berkoordinasi dalam penyusunan rencana pelayanan pasien *stunting* dan *wasting*
- 3) Setiap profesi memberikan intervensi sesuai kompetensi masing-masing profesi.
- 4) Anggota tim saling memberikan informasi terkait kondisi pasien.
- 5) Dilakukan diskusi tim secara berkala

2. Hubungan Unit Pelayanan di rumah Sakit

a. Instalasi Rawat Jalan

- 1) Tim *Stunting* dan *Wasting* menerima rujukan pasien dari rawat jalan.
- 2) Tim *Stunting* dan *Wasting* memberikan rekomendasi pelayanan lanjutan.
- 3) Tim *Stunting* dan *Wasting* berkoordinasi dalam monitoring pasien

b. Instalasi Rawat Inap

- 1) Tim *Stunting* dan *Wasting* melakukan asesmen dan intervensi pada pasien rawat inap.
- 2) Berkoordinasi dengan DPJP dan perawat ruangan.
- 3) Memberikan rekomendasi pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

3. Hubungan Eksternal Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

a. Tim menjalin koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jejaring, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan dinas kesehatan dalam rangka kesinambungan pelayanan pasien.

b. Koordinasi mencakup rujukan, rujukan balik, pencatatan dan pelaporan.



BAB III TATALAKSANA

3.1 Identifikasi dan Penetapan Pasien Risiko *Stunting* dan *Wasting*

1. Petugas melakukan skrining dan deteksi dini untuk mengidentifikasi pasien dengan risiko stunting dan/atau wasting, meliputi:
 - a. Pengukuran antropometri berupa BB, PB/TB, dan LILA (usia 6-59 bulan)
 - b. Perhitungan dan interpretasi z-score berdasarkan standar WHO berupa PB/U atau TB/U (deteksi stunting) dan BB/PB atau BB/TB (deteksi wasting) dengan klasifikasi status gizi:
 - 1) Stunting : PB/U atau TB/U < -2 SD
 - 2) Wasting : BB/PB atau BB/TB < -2 SD
 - 3) Severe wasting : BB/PB atau BB/TB < -3 SDdan/atau LILA < 11,5 cm dan/atau edema bilateral
 - c. Pengidentifikasian tanda bahaya berupa edema bilateral, tidak sadar, tidak mau makan, dehidrasi dan infeksi berat
 - d. Balita (usia 0 – 59 bulan) dengan masalah pertumbuhan
 - e. Balita (usia 0 – 59 bulan) dengan riwayat berat badan tidak naik atau penurunan berat badan
 - f. Balita (usia 0 – 59 bulan) dengan penyakit kronis atau infeksi berulang
 - g. Ibu hamil dengan risiko kekurangan energi kronis atau anemia
2. Identifikasi dilakukan di seluruh unit pelayanan, antara lain:
 - a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - b. Rawat Jalan (terutama poli anak dan poli kandungan)
 - c. Rawat Inap
3. Pasien yang memenuhi kriteria dirujuk kepada Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* untuk penanganan lanjut.

3.2 Assesmen dan Penilaian Komprehensif

Tim pelayanan stunting dan wasting melakukan assesmen menyeluruh, meliputi:

1. Anamnesis
 - a. Faktor Ibu
 - 1) Riwayat status gizi ibu
 - 2) Riwayat ibu di masa prakonsepsi
 - 3) Riwayat kehamilan
 - 4) Riwayat penyakit infeksi
 - b. Faktor Anak
 - 1) Riwayat BBLR
 - 2) Praktik pemberian ASI
 - 3) Pola pemberian MPASI
 - 4) Riwayat imunisasi
 - 5) Riwayat penyakit infeksi
 - c. Faktor Lingkungan
 - 1) Kondisi dan dukungan keluarga
 - 2) Pola asuh dan pola makan
 - 3) Sanitasi lingkungan
2. Pemeriksaan Fisik
 - a. Pengukuran Antropometri
 - 1) Pengukuran antropometri berupa BB, PB/TB, dan LILA (usia 6-59 bulan)
 - 2) Perhitungan dan interpretasi z-score berdasarkan standar WHO berupa PB/U atau TB/U (deteksi stunting) dan BB/PB atau BB/TB (deteksi wasting) dengan klasifikasi status gizi:
 - Stunting : PB/U atau TB/U < -2 SD
 - Wasting : BB/PB atau BB/TB < -2 SD



- Severe wasting : BB/PB atau BB/TB < -3 SD
dan/atau LILA < 11,5 cm dan/atau edema bilateral
- b. Tanda klinis kekurangan gizi
- c. Deteksi edema dan komplikasi
- 3. Pemeriksaan Penunjang
 - a. Pemeriksaan laboratorium
 - b. Skrining TBC
 - c. Skrining kelainan metabolik
- 3.3 Penyusunan Rencana Pelayanan Terpadu
 - 1. Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* menyusun rencana pelayanan berdasarkan hasil assesmen.
 - 2. Rencana pelayanan meliputi:
 - a. Tata laksana medis sesuai diagnosis
 - b. Intervensi gizi
 - c. Edukasi
 - d. Suplementasi dan terapi nutrisi
 - e. Dukungan psikososial keluarga
 - 3. Rencana pelayanan didokumentasikan dalam rekam medis.
 - 4. Rencana dikomunikasikan kepada orang tua atau keluarga pasien, serta seluruh anggota tim.
- 3.4 Pelaksanaan Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*
 - 1. Setiap anggota tim melaksanakan intervensi sesuai rencana pelayanan, dan kompetensi masing-masing profesi.
 - 2. Pelayanan dilakukan secara multidisiplin.
 - 3. Dilakukan koordinasi antar anggota tim.
 - 4. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
- 3.5 Monitoring Evaluasi Pasien *Stunting* dan *Wasting*
 - 1. Tim melakukan pemantauan kondisi pasien *stunting* dan/atau *wasting* secara berkala.
 - 2. Dilakukan evaluasi meliputi:
 - a. Perkembangan kondisi dan status gizi
 - b. Kepatuhan terhadap intervensi
 - d. Risiko komplikasi
 - 3. Dilakukan penyesuaian rencana pelayanan bila diperlukan.



BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

1. Tujuan Monitoring
 - a. Mengidentifikasi masalah secara dini
 - b. Mencegah komplikasi
 - c. Menjamin pelayanan sesuai standar
2. Monitoring Tim
 - a. Diskusi kasus multidisiplin
 - b. Rapat Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* mingguan/bulanan
 - c. Evaluasi rencana pelayanan
3. Monitoring Kepatuhan terhadap Prosedur
 - a. Kepatuhan terhadap asesmen *stunting* dan *wasting*
 - b. Kepatuhan dokumentasi rekam medis
 - c. Kepatuhan terhadap pencatatan dan pelaporan

4.2 Evaluasi

1. Evaluasi Klinis Pasien
 - a. Perkembangan kondisi dan status gizi
 - b. Kepatuhan terhadap intervensi
 - d. Risiko komplikasi

Bila hasil tidak optimal, maka:

 - a. Dilakukan revisi rencana pelayanan
 - b. Dilakukan konsultasi tambahan
 - c. Dilakukan intervensi lanjutan
2. Evaluasi Program Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*
 - a. Tujuan:
 - 1) Menilai efektivitas pelayanan
 - 2) Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan
 - 3) Mendukung program peningkatan mutu (PMKP)
 - b. Evaluasi sumber daya
 - 1) Ketersediaan SDM
 - 2) Ketersediaan sarana dan prasarana
 - 3) Kebutuhan pelatihan

4.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan *Stunting* dan *Wasting* kepada manajemen rumah sakit

1. Pelaporan Internal

Pelaporan kegiatan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/tahunan).
2. Pelaporan Eksternal

Data pasien *stunting* dan/atau *wasting* dilaporkan pada Dinas Kesehatan wilayah setempat untuk dilakukan pengecekan dan pencatatan dalam aplikasi "PELITA KESMAS".



BAB V PENUTUP

Pedoman Kerja Tim Pelayanan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan pelayanan *stunting* dan *wasting* yang komprehensif, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan, dengan melibatkan tim multidisiplin sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung terselenggaranya pelayanan yang bermutu, efektif, efisien, serta berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan adanya pedoman ini, seluruh anggota Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* serta unit terkait di rumah sakit diharapkan dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional, terintegrasi, serta sesuai dengan standar pelayanan, standar akreditasi rumah sakit, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta peningkatan mutu pelayanan *stunting* dan *wasting* secara berkelanjutan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dilakukan evaluasi serta peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pelayanan, serta perubahan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pelayanan *stunting* dan *wasting* di rumah sakit dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang paripurna dan berorientasi pada keselamatan pasien. Demikian Pedoman Kerja Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* Rumah Sakit Pima Husada Sukkorejo disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep